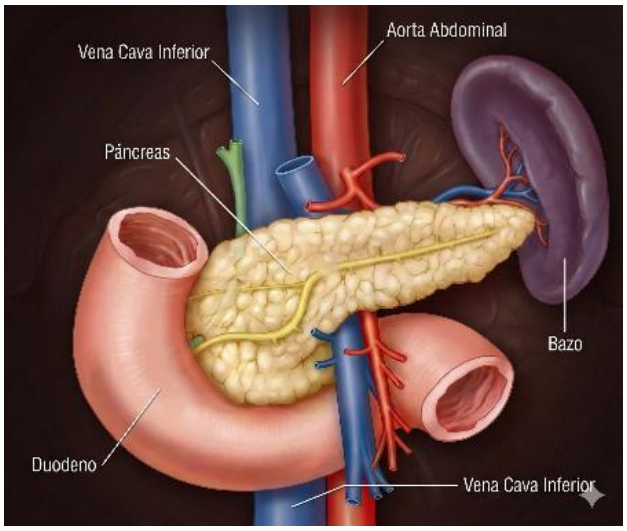
PANCREATECTOMÍA CORPOCAUDAL CON ESPLENECTOMÍA

Mª Elisa de Castro Peraza, Judith Reguera Cabrera, María Pérez López, Lidia García González, Estefanía Rodríguez Izquierdo, Nieves Lorenzo Rocha

DEFINICIÓN Y OBJETIVOS

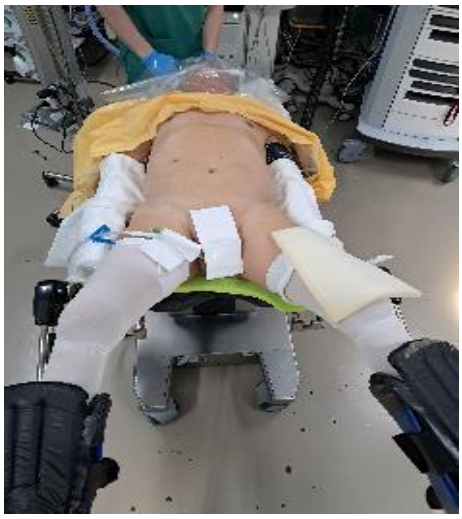


La pancreatectomía corpocaudal o pancreatectomía distal consiste en la resección del cuerpo y la cola del páncreas Está indicada en lesiones localizadas en este segmento, frecuentemente tumorales, que no comprometen el duodeno ni la vía biliar principal. El objetivo es extirpar la lesión con márgenes adecuados, trabajando en el plano retropancreático, y asegurar un control vascular seguro del territorio esplénico.

La intervención puede realizarse con preservación del bazo cuando se trata de tumores benignos o de bajo grado y no existe afectación del hilio ni de los vasos esplénicos. En cambio, si la lesión es maligna, está muy próxima a la cola o compromete los vasos esplénicos, suele asociarse a una esplenectomía, ya que facilita una resección oncológica completa, permite la linfadenectomía regional y evita complicaciones por isquemia o congestión esplénica tras la disección.

POSICIÓN QUIRÚRGICA DEL PACIENTE

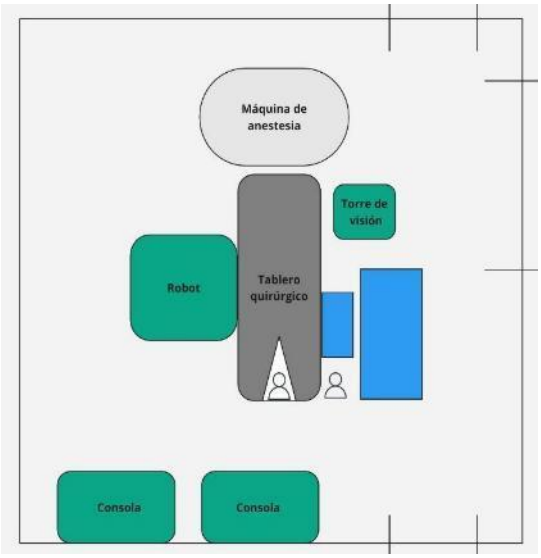




- Brazos alineados con el cuerpo.
- Decúbito supino.
- Perneras bajas.
    - **Importante**: Proteger con foam ambas rodillas y muslos, especialmente la izquierda, ya que los brazos del robot pueden contactar con el paciente.
- Almohada de silicona para la cabeza.

POSICIÓN DEL EQUIPO QUIRÚRGICO Y CONFIGURACIÓN DEL DA VINCI

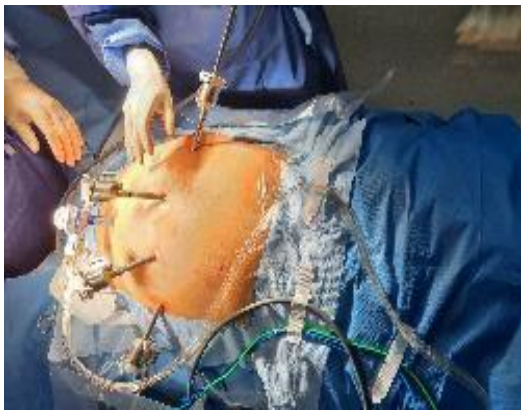
- Anatomía: Abdominal superior
- Lado: Derecho
    - Brazo 1: Bipolar fenestrada
    - Brazo 2: Endoscopio 30º
    - Brazo 3 (trocar de 12mm): Bipolar maryland / Vesselsealer
    - Brazo 4: Tip - up
- Tablero quirúrgico:
    - Anti-trendelemburg 11°
    - Lateral izquierdo 5°



- Valorar bajar la altura de las piernas ligeramente como protección extra contra los brazos del robot.

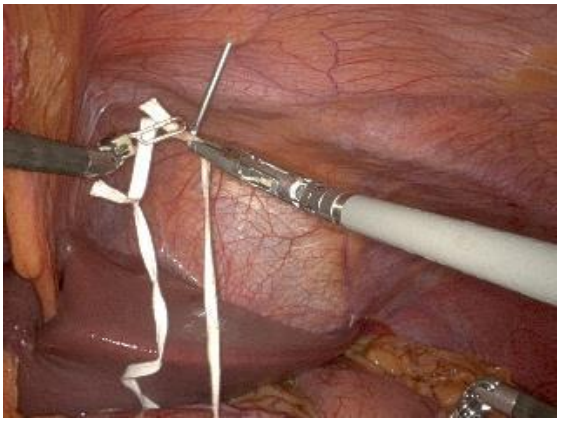
TÉCNICA QUIRÚRGICA

- Preparación del campo y colocación de trócares. Puede ser necesario utilizar dos pinzas con energía bipolar. En ese caso, hay que colocar el segundo cable bipolar del Da Vinci que es un extra a la caja de accesorios.



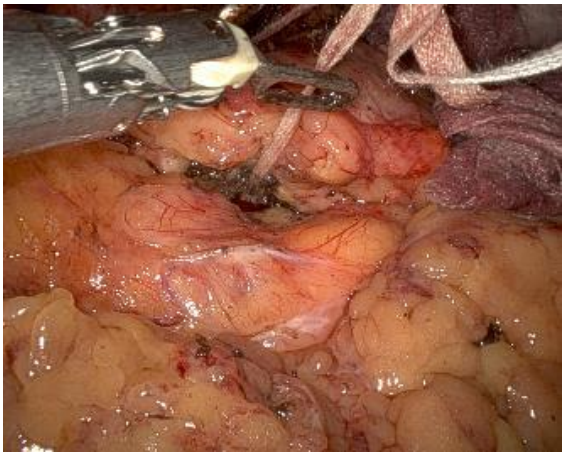


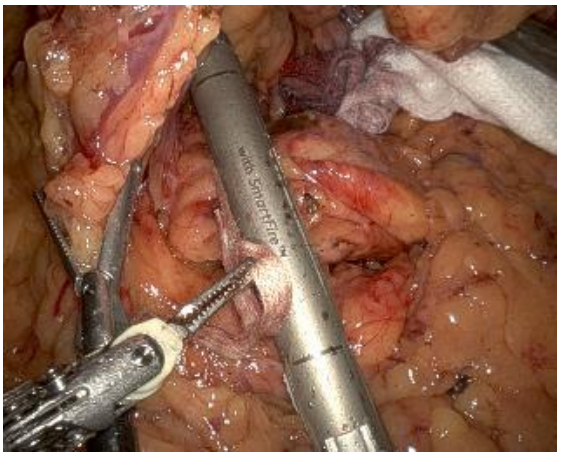
- Se comienza con la sección del epiplon mayor para poder acceder a la transcavidad de los epiplones y tener acceso a la cara anterior o ventral del páncreas. Esta sección se continúa con los vasos gástricos cortos próximos al bazo.
- Se tracciona del estómago hacia la pared abdominal anterior para favorecer la liberación del páncreas. Para ello se utiliza una cinta umbilical que abarca desde la curvatura mayor a la menor y que se saca al exterior de la cavidad con un pasahilos.



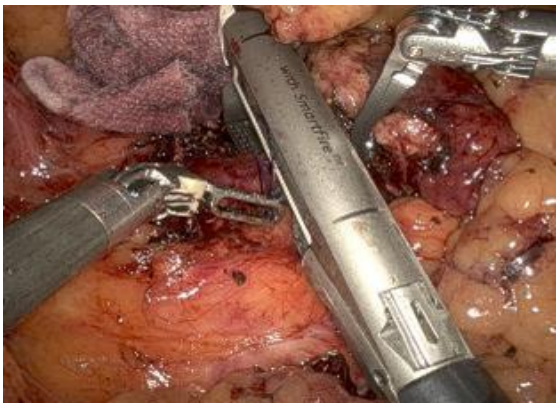
- Disección de la cara inferior del páncreas, desde donde se accederá a la posterior para así liberarlo en toda su circunferencia. De este modo se puede pasar una cinta de referencia cortada a 20 cm y clipar sus extremos. Es posible que haya que movilizar el ángulo esplénico del colon en esta maniobra.

- Pasada la cinta alrededor del páncreas, éste se podrá traccionar y movilizar para exponer los siguientes planos de trabajo.
- Durante la disección del páncreas, pueden extirparse adenopatías.
- Localización del paquete vascular esplénico. En ese momento se puede querer dejar la arteria y la vena referenciados para traccionar ligeramente de ellos al pasar la carga. Esta referencia se hace con hilo de vicryl 0 cortado a 10cm, por si quedase atrapado en la línea de grapas (hilo absorbible).
- En caso de sangrado vascular, se prepara sutura de Prolene cortada a 15 cm con un pledget.
- Se secciona el cuerpo del páncreas con la grapadora robótica sureform y una carga verde o negra, según el grosor. En ocasiones, el tejido pancreático está tan engrosado por la enfermedad que puede quedar parte del muñón abierto. En este caso es necesario su cierre o reforzar la línea de grapas con punto de sutura tipo V-loc 3-0 o monocryl.



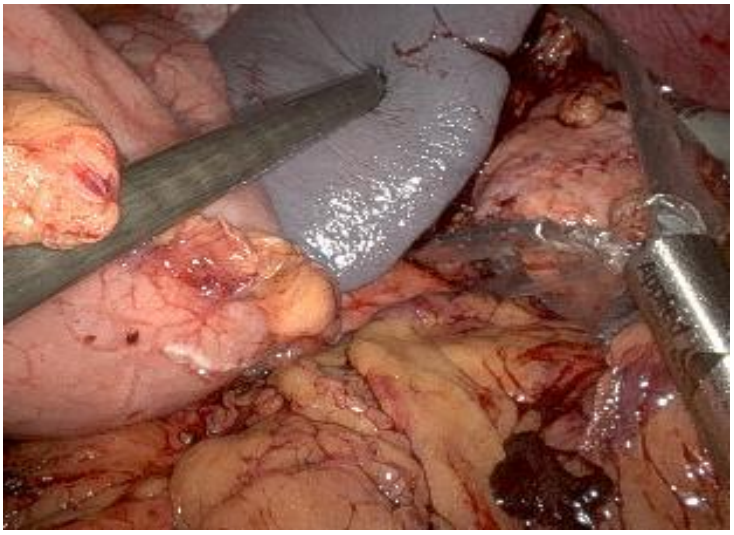


- En el caso de que se realice esplenectomía, se secciona con carga vascular primero la arteria esplénica, y posteriormente la vena. De este modo, evitamos la pérdida de sangre que pueda quedar atrapada en el bazo si lo hacemos en el sentido inverso.



- Se continua con la disección de la cola y el bazo hasta su completa liberación.
- Embolsado de las piezas, revisión de hemostasia y aplicación de hemostático sellante tipo Tisseal.





- Colocación de drenaje conectado a vacío de baja presión.
- Se realiza incisión de asistencia para sacar las piezas.
- Cierre de heridas y colocación de apósitos.

BIBLIOGRAFÍA

1. Thebault, B., Quetel, R., Peyrafort, P., & Saint-Marc, O. (2025). Pancreatectomías mínimamente invasivas con asistencia robótica. *EMC - Técnicas Quirúrgicas - Aparato Digestivo; Volume 41, Issue 1, Page 1-13 ; ISSN 1282-9129*. https://doi.org/10.1016/s1282-9129(25)50132-0
2. Fernández-Cruz L, Orduña D, Cesar-Borges G, López-Boado MA. Distal pancreatectomy: en-bloc splenectomy vs spleen-preserving pancreatectomy. HPB (Oxford). 2005;7(2):93-98. doi:10.1080/13651820510028972. PubMed+1
3. Tsiouris A, Cogan CM, Velanovich V. Distal pancreatectomy with or without splenectomy: comparison of postoperative outcomes and surrogates of splenic function. HPB (Oxford). 2011;13(10):738-744. doi:10.1111/j.1477-2574.2011.00369.x. PubMed
4. Kimura W, Yano M, Sugawara S, Okazaki S, Sato T, Moriya T, et al. Spleen-preserving distal pancreatectomy with conservation of the splenic artery and vein: techniques and its significance. J Hepatobiliary Pancreat Sci. 2010;17(6):813-823. doi:10.1007/s00534-009-0250-z. PubMed
5. Adam JP, Jacquin A, Laurent C, Collet D, Masson B, Fernández-Cruz L, Sa-Cunha A. Laparoscopic spleen-preserving distal pancreatectomy: splenic vessel preservation compared with the Warshaw technique. JAMA Surg. 2013;148(3):246-252. doi:10.1001/jamasurg.2013.768. PubMed
6. Wang L, Wu D, Cheng YG, Xu J, Chu H, Zhang G, et al. Warshaw technique in laparoscopic spleen-preserving distal pancreatectomy: surgical strategy and late outcomes of splenic preservation. Biomed Res Int. 2019;2019:4074369. doi:10.1155/2019/4074369. Wiley Online Library+1
7. Partelli S, Cirocchi R, Randolph J, Parisi A, Coratti A, Falconi M. A systematic review and meta-analysis of spleen-preserving distal pancreatectomy with preservation or ligation of the splenic artery and vein. Surgeon. 2016;14(2):109-118. doi:10.1016/j.surge.2015.11.002. PubMed+1
8. van Ramshorst TME, van Bodegraven EA, Al-Samman MA, Bassi C, Boggi U, Dokmak S, et al. Robot-assisted versus laparoscopic distal pancreatectomy: a systematic review and meta-analysis including patient subgroups. Surg Endosc. 2023;37(6):4131-4143. doi:10.1007/s00464-023-09894-y.